E-Carnet — Business plan et modèle de revenus

Version du 24 octobre 2026 · Montants en FCFA · Document de travail destiné aux partenaires et investisseurs

À lire avant utilisation : les prix, volumes et coûts présentés sont des hypothèses à tester auprès d'établissements. Ils ne constituent ni des devis ni des tarifs définitivement validés. Les montants liés à la conformité et à la sécurité devront être confirmés par des professionnels. La conversion indicative retenue est de 656 FCFA pour 1 €, sans garantie. Les chiffres financiers sont inchangés par rapport à la version précédente : seule la description de l'état du produit a été mise à jour.

1. Résumé du projet

Aujourd'hui, les informations de santé peuvent rester dans des carnets papier ou être dispersées entre plusieurs établissements. E-Carnet propose au patient un carnet de santé numérique qu'il consulte sur téléphone et dont il contrôle le partage.

Le patient choisit quand donner accès à certaines informations, à qui et pour combien de temps. Le produit distingue les informations déclarées par le patient, les documents ajoutés et les informations confirmées par un professionnel de santé.

État actuel : la version 1 et une grande partie de la version 2 sont développées. Le produit peut être présenté avec des données fictives. Il ne doit pas encore recevoir de véritables données de santé : l'hébergement, les vérifications de sécurité, les validations médicales et juridiques et les tests de mise en service doivent d'abord être approuvés.

Ce qui a avancé récemment : un médecin garde un seul compte avec deux espaces séparés (son propre carnet de patient et son espace professionnel) ; il ne peut jamais ouvrir son propre dossier côté professionnel. Le parcours du médecin est plus simple (carte « Mise en route », dossier médecin, rattachement par code, scan de QR par la caméra) et l'établissement voit son équipe avec les photos et remet un code valable 48 heures. Un audit de sécurité du 23/10 a corrigé trois failles. L'interface a été uniformisée (tuiles aux couleurs de la palette choisie, même effet « goutte » partout).

Le modèle proposé repose sur trois sources de financement : les établissements de santé, les organisations qui financent le service pour leurs membres et les programmes de santé publique. Le carnet reste gratuit pour le patient et les données médicales ne sont ni vendues ni utilisées à des fins commerciales.

Besoin de financement indicatif : environ 10 millions FCFA (environ 15 000 €) en pré-amorçage, pour couvrir la préparation d'environ 5 mois, puis la trésorerie des deux premières années d'activité.

Aucun revenu ne doit démarrer avant la mise en place du statut juridique, la confirmation des démarches auprès de l'ARTCI et la validation de l'hébergement. Les délais réglementaires mentionnés restent à confirmer.

2. Ce qui existe déjà et ce qu'il reste à construire

Offre envisagée	Déjà présent dans le produit	À construire ou à confirmer
Établissements de santé (A)	Création d'un établissement et de son administrateur ; rattachement des médecins par code (code remis valable 48 h, visible de l'administrateur) ; équipe avec photos ; décision sur les demandes en attente ; consultations signées ; ordonnances personnalisées (logo et en-tête) ; journal des accès ; séparation stricte entre établissements.	Suivi des abonnements et de la facturation, tableau de bord de l'établissement, plusieurs administrateurs avec rôles.
Organisations qui financent leurs membres (B)	Carnet complet, vaccinations, rappels, carte d'urgence, pré-consultation simplifiée.	Fonction permettant de rattacher des groupes de comptes à une organisation payeuse.
Programmes de santé publique (C)	Vaccinations avec trois niveaux de preuve, rappels, plans de suivi, notifications.	Statistiques anonymisées et limitées au nécessaire (lot C de la V2, non réalisé), exports regroupés.

Au départ, les trois offres seront facturées sur contrat, sans paiement en ligne intégré. Le paiement Mobile Money est prévu en V3 et n'est donc pas indispensable pour commencer.

3. Marché et positionnement

Le marché de la santé numérique existe déjà en Côte d'Ivoire. E-Carnet devra démontrer sa valeur par la qualité de son exécution locale et par la confiance qu'il inspire, plutôt que par la seule nouveauté de l'idée. L'étude interne de référence date du 18/10/2026.

Acteur ou référence	Offre connue	Point de comparaison
Orange Santé avec DabaDoc (lancé en 2022)	Rendez-vous, paiement de téléconsultations, dossiers médicaux numérisés, gestion des centres.	Concurrent direct adossé à un opérateur.
Pass Santé Mousso	Carnet par bracelet ou carte, dossier, rendez-vous, téléconsultation, paiement.	Chiffres déclarés par le projet en 2024 : plus de 32 000 personnes suivies, 125 médecins et 88 centres. Ces chiffres ne sont pas audités.
Références étrangères : Mon espace santé, My Health Record, NHS App, ABHA	Dossier personnel de santé intégré à un système public.	Montrent une direction possible du marché, mais E-Carnet ne dispose pas de cette intégration institutionnelle.

Différences qu'E-Carnet souhaite démontrer : le patient comprend les autorisations qu'il donne ; les informations déclarées sont distinguées des documents et des informations confirmées ; l'outil reste simple sur téléphone et avec une connexion lente ; aucun établissement n'est privilégié.

La taille du marché n'est pas chiffrée dans ce document, faute de données sourcées sur le nombre d'établissements privés, la population ciblée et les budgets de santé. Cette recherche reste à faire avant un dossier définitif.

4. Les trois sources de revenus proposées

4.1. A — Abonnement des établissements

Palier	Taille de l'établissement	Abonnement mensuel
Petit	1 à 3 praticiens	15 000 FCFA
Moyen	4 à 10 praticiens	35 000 FCFA
Grand	11 praticiens et plus	75 000 FCFA

Frais de mise en service et de formation : 150 000 FCFA par établissement, une seule fois. Hypothèse de répartition des clients : 60 % petits, 30 % moyens et 10 % grands. Cela donne un abonnement moyen supposé de 27 000 FCFA par mois, soit 324 000 FCFA par an et par établissement. Un contrat annuel payé d'avance est privilégié pour réduire les retards de paiement.

C'est la source de revenus la plus directement liée au produit actuel : les établissements utilisent déjà les fonctions de rattachement, de consultation et d'ordonnance.

4.2. B — Organisations qui financent le carnet de leurs membres

Les employeurs, mutuelles, assureurs, écoles et universités pourraient payer 1 500 FCFA par membre et par an, soit environ 125 FCFA par mois. Le patient ne paie pas.

Règle de confiance : l'organisation ne voit jamais les données médicales de ses membres. Elle reçoit uniquement des indicateurs d'activation, et seulement si le cadre juridique le permet. Exemples envisagés : carnet vaccinal des élèves et rappels de prévention pour les salariés.

Cette offre nécessite de créer la fonction permettant de gérer les organisations et les groupes de comptes ; elle n'existe pas encore dans le produit.

4.3. C — Programmes de santé publique

Hypothèse de prix : 8 millions FCFA par programme et par an, pour une licence, la maintenance et la formation. Exemples : suivi vaccinal d'une campagne, santé maternelle et maladies chroniques.

Le cycle de vente pourrait durer plusieurs mois, voire plus d'un an. Cette source ne doit donc pas être considérée comme indispensable au démarrage. Elle nécessite des statistiques anonymisées et limitées au nécessaire, un cadre juridique adapté et des partenaires officiels identifiés.

4.4. Autres pistes non incluses dans les prévisions

Une offre premium patient à 2 000 FCFA par an (qui dépend du paiement Mobile Money prévu en V3), des cartes d'urgence physiques, des subventions et des prix d'innovation pourraient compléter le modèle. Aucun revenu de ces pistes n'est compté dans les prévisions.

> **Principe non négociable : E-Carnet ne vend pas les données de santé et ne les valorise pas pour le marketing, la revente ou l'entraînement de modèles. La confiance des patients dépend de cette règle.**

5. Prévisions sur trois ans

Convention : l'An 1 commence à l'ouverture réelle du service, après validation du statut, des démarches auprès de l'ARTCI et de l'hébergement. La période de préparation précède l'An 1. Les établissements actifs, membres couverts et programmes sont comptés en fin d'année.

Hypothèse de fin d'année	Prudent (An 1 / 2 / 3)	Base (An 1 / 2 / 3)	Ambitieux (An 1 / 2 / 3)
Établissements actifs	8 / 20 / 40	15 / 40 / 80	20 / 70 / 150
Membres couverts par des organisations (B)	0 / 2 000 / 8 000	0 / 5 000 / 20 000	2 000 / 15 000 / 50 000
Programmes actifs (C)	0 / 0 / 1	0 / 1 / 2	0 / 2 / 4

5.1. Revenus du scénario de base (en millions de FCFA)

Source de revenus	An 1	An 2	An 3
A. Abonnements	2,43	8,91	19,44
A. Mise en service	2,25	3,75	6,00
B. Organisations	0	3,75	18,75
C. Programmes	0	4,00	12,00
Total des revenus	**4,68**	**20,41**	**56,19**

5.2. Résultat des trois scénarios (en millions de FCFA)

Scénario	Revenus An 1 / 2 / 3	Résultat An 1 / 2 / 3	Cumul fin An 3
Prudent	2,50 / 7,84 / 24,22	-6,33 / -1,80 / +9,28	+1,15
Base	4,68 / 20,41 / 56,19	-4,20 / +6,43 / +32,29	+34,53
Ambitieux (plafond théorique)	7,74 / 42,83 / 120,39	-1,20 / +24,29 / +83,42	+106,51

Lecture prudente : la source A est aujourd'hui la seule qui dispose d'un chemin commercial concret soutenu par les fonctions existantes. Si B et C restent à zéro dans le scénario de base, les revenus de l'An 3 sont d'environ 25,4 millions FCFA contre 23,2 millions de charges, soit un résultat proche de +2 millions FCFA. Le scénario ambitieux illustre un potentiel et ne doit pas servir de plan de dépenses.

Le besoin de trésorerie estimé atteint -4,2 millions FCFA à la fin de l'An 1 dans le scénario de base et -8,1 millions FCFA à la fin de l'An 2 dans le scénario prudent, auxquels s'ajoutent environ 2 millions FCFA pour la préparation.

6. Charges et utilisation des fonds

6.1. Charges du scénario de base (en millions de FCFA)

Poste	An 1	An 2	An 3
Équipe (fondateur développeur à 250 000 FCFA/mois, puis recrutements)	4,80	9,00	15,00
Commercial et événements	0,60	1,50	3,00
Infrastructure et services (VPS, sauvegardes, domaine, e-mail SMTP)	0,45	0,70	1,20
Mise en production (une fois)	0,33	—	—
Conformité et sécurité (ARTCI, juriste, revue de sécurité)	1,50	0,60	0,60
Comptabilité et juridique courants	0,30	0,50	0,80
Frais de paiement et d'encaissement (2 % des revenus)	0,09	0,41	1,12
Réserve de 10 %	0,81	1,27	2,17
Total	**8,88**	**13,98**	**23,90**

Repère d'infrastructure : le VPS Hodi de 2 vCPU et 4 Go cité par le porteur coûte 10 990 FCFA par mois en promotion, soit environ 132 000 FCFA par an. Ce prix doit être confirmé par écrit et après la fin de la promotion. Le budget d'infrastructure inclut une marge pour les sauvegardes locales, le domaine et l'e-mail transactionnel.

Provisions de conformité : environ 300 000 FCFA pour une consultation juridique et les démarches de statut, 1 000 000 FCFA pour une revue de sécurité indépendante et 200 000 FCFA pour les formalités. Ces montants doivent être remplacés par des devis.

6.2. Utilisation envisagée d'un financement de 10 millions FCFA

Poste	Montant	Part
Équipe (préparation et début d'exploitation)	4,5 M FCFA	45 %
Conformité, juridique et sécurité	1,8 M FCFA	18 %
Hébergement en Côte d'Ivoire et mise en production	0,8 M FCFA	8 %
Commercial, pilotes et événements	1,0 M FCFA	10 %
Comptabilité, juridique courant et frais de paiement	0,4 M FCFA	4 %
Réserve	1,5 M FCFA	15 %
Total	**10,0 M FCFA**	**100 %**

Les développements V3 et V6 ne sont pas financés par cette levée. Les coûts des SMS, de la visioconférence WebRTC, du prestataire de paiement et de l'équipe supplémentaire devront être chiffrés lorsque le pilote aura produit des résultats.

7. Plan sans levée de fonds

Sans investissement, le projet peut avancer avec un fonctionnement réduit et le fondateur non rémunéré. Ce coût de travail non payé doit être reconnu clairement.

- Charges récurrentes minimales estimées : environ 750 000 FCFA par an, soit 450 000 FCFA d'infrastructure et 300 000 FCFA de comptabilité.
- Trois établissements payants couvriraient ces charges récurrentes : 3 × 324 000 = 972 000 FCFA par an.
- Cinq à six établissements couvriraient aussi les frais uniques de conformité et de mise en production (environ 1,8 million FCFA) la première année, frais de mise en service compris.
- Une variante à 2 000 FCFA par patient et par an donnerait 2 millions FCFA pour 1 000 patients, mais dépend du paiement Mobile Money prévu en V3. Un encaissement manuel est possible, mais lourd.
- Conséquence : la croissance serait lente, sans commercial dédié et sans capacité à financer la conformité avant les premiers contrats.

8. Calendrier et conditions avant ouverture

Étape	Durée indicative	Condition ou point à confirmer
Préparation	Environ 5 mois ; coût estimé : 2 M FCFA	Statut juridique via CEPICI, dossier ARTCI, hébergement en Côte d'Ivoire, remplacement de Cloudinary, environnement de test séparé, revue de sécurité et avis juridique. S'y ajoutent l'exécution des tests Python, les essais sur téléphones réels et les 4 vérifications de l'audit du 23/10.
Démonstrations et accords de principe	Dès maintenant	Données fictives uniquement. Démonstrations sans collecte de vraies données de santé.
Autorisation ARTCI pour données médicales et transferts	Au moins 2 mois d'instruction selon l'hypothèse ; silence valant rejet à confirmer	Contact indiqué dans le document : infos-apdp@artci.ci.
Facturation	Avant la première facture	Immatriculation puis inscription à la FNE de la DGI.
Pilote avec de vraies données	Après la préparation	Décision formelle autorisant le lancement après validation de l'hébergement, des sauvegardes testées et des points médicaux et juridiques.
Paiement en ligne	V3	Contrat avec un prestataire de paiement agréé.

Un pilote gratuit avec de vrais patients peut entraîner les mêmes obligations qu'un pilote payant. Les délais et obligations réglementaires doivent être confirmés par les autorités et les juristes.

9. Principaux risques et réponses prévues

Risque	Conséquence possible	Réponse prévue
Délai ARTCI plus long que prévu	Retard des revenus	Déposer le dossier pendant la préparation ; privilégier l'hébergement en Côte d'Ivoire pour éviter un transfert international lorsque c'est possible ; limiter les données collectées.
Concurrence (Orange Santé, Pass Santé Mousso)	Adoption plus difficile	Mettre en avant l'exécution locale et la neutralité ; réaliser 5 tests utilisateurs.
Adoption lente par les établissements	Retard des revenus A	Formation lors de la mise en service, contrat annuel prépayé et démonstration sur place.
Prix non validés	Prévisions financières fragiles	Tester les paliers auprès d'au moins 10 établissements avant de les figer.
Dépendance au fondateur	Risque de continuité	Documenter le projet et prévoir un premier recrutement technique au financement.
Incident de sécurité ou perte de données	Perte de confiance et risque juridique	Revue indépendante, sauvegardes testées et plan de réponse aux incidents. Un audit interne du 23/10 a déjà corrigé trois failles ; il reste à l'exécuter en préproduction.
Communication qui ne reflète pas l'état réel	Perte de confiance	Afficher « Démonstration — données fictives » jusqu'à la levée des conditions de lancement.
Coûts V3 qui augmentent	Tension de trésorerie	Ne lancer V3 qu'avec des revenus et un financement dédié.

10. Indicateurs à suivre

- Nombre d'établissements actifs et revenu mensuel récurrent.
- Nombre de médecins rattachés à chaque établissement.
- Nombre de patients actifs chaque mois.
- Part des demandes d'accès acceptées par les patients, comme indicateur de confiance.
- Nombre de documents et de vaccinations ajoutés par patient.

- Fidélisation des utilisateurs à 90 jours.
- Coût d'infrastructure par patient actif.
- Capacité à retrouver une information importante en moins d'une minute.
- Satisfaction mesurée par l'enquête d'expérience déjà présente dans le produit.

11. Préparation d'Ivoire Tech

- Faire des démonstrations avec des données fictives uniquement ; ne pas créer de vrais comptes patients sur le stand.
- Afficher clairement « Démonstration — données fictives » à l'écran et sur le site.
- Présenter le parcours de partage : le patient génère un QR code, le médecin le scanne avec la caméra, puis le patient autorise ou révoque l'accès.
- Montrer qu'un médecin a deux espaces séparés (patient et professionnel) avec un seul compte, et qu'il ne peut pas ouvrir son propre dossier.
- Viser 10 entretiens avec des établissements et 5 lettres d'intention non engageantes pour tester les prix.
- Présenter les trois sources de revenus et les principes de protection des données, notamment l'hébergement ivoirien visé et l'accès autorisé par le patient.
- Préparer une fiche d'une page avec les offres prévues, sans promettre les fonctions des versions V3 et V6.

12. Prochaines étapes

- Obtenir les réponses écrites de Hodi sur les technologies compatibles, les sauvegardes, la restauration, le centre de données et le contrat de sous-traitance.
- Contacter l'ARTCI pour confirmer le régime applicable aux données médicales et aux transferts ; adresse indiquée : infos-apdp@artci.ci.
- Choisir le statut juridique avec le guichet unique.
- Remplacer Cloudinary par un stockage privé local avant tout essai avec de vraies données.
- Exécuter les tests Python et les 4 vérifications de préproduction de l'audit du 23/10, puis tester sur téléphones réels.
- Documenter la taille du marché avec des sources vérifiables.
- Tester les prix auprès d'au moins 10 établissements puis actualiser le document.

Fin du document — les hypothèses financières et réglementaires doivent être vérifiées avant toute diffusion comme engagement ferme.